

Balão Intragástrico Spatz

Tratamento Endoscópico da Obesidade — Uma abordagem minimamente invasiva, ajustável e clinicamente segura para o manejo da obesidade



O que é o Balão Intragástrico Spatz?

O balão intragástrico Spatz é um **dispositivo endoscópico ajustável** utilizado no tratamento da obesidade. Posicionado no interior do estômago, promove **saciedade precoce** e redução consistente da ingestão alimentar, sem necessidade de cirurgia.

Endoscópico

Inserção e remoção via endoscopia, sem incisões

Ajustável

Volume adaptável ao longo do tratamento

Reversível

Removido ao final do período terapêutico



Diferencial do Spatz: O Único Balão Ajustável



Ao contrário dos balões convencionais, o Spatz permite **ajuste de volume durante o tratamento**, seja para aumentar o efeito terapêutico ou reduzir desconfortos.

Aumento de volume

Intensifica a saciedade quando necessário

Redução de volume

Alivia intolerâncias e efeitos adversos

Maior personalização

Resposta terapêutica individualizada ao paciente

Mecanismo de Ação: Ocupação Gástrica



**Estômago
Vazio**

**Grande capacidade
para alimentos**



**Estômago com
Balão Intragástrico**

**Espaço reduzido,
menor capacidade**

O balão **ocupa fisicamente o espaço intragástrico**, reduzindo o volume disponível para alimentos. Esse mecanismo resulta em:

- Menor capacidade gástrica funcional
- Sensação de plenitude com refeições menores
- Redução natural do volume ingerido por refeição
- Retardo do esvaziamento gástrico

Mecanismo de Ação: Saciedade Neural



Distensão Gástrica

Sinal Aferente Vagal

Redução do Apetite

A distensão promovida pelo balão ativa **mecanorreceptores na parede gástrica**, gerando sinais aferentes via nervo vago ao hipotálamo — resultando em supressão do apetite e antecipação da saciedade.

Mecanismo de Ação: Adaptação Progressiva

Com o tempo, o organismo se **adapta gradualmente** à presença do balão. O desconforto inicial diminui e o paciente passa a tolerar a nova dinâmica gástrica, permitindo ingestão controlada, regular e sem sofrimento, desde que associada ao suporte nutricional adequado.



Indicações Clínicas

1

IMC 30–40 kg/m²

Obesidade grau I ou II, com ou sem comorbidades associadas

2

Falha no tratamento clínico

Insucesso após dieta, exercício e farmacoterapia por pelo menos 6 meses

3

Alto risco cirúrgico

Pacientes não elegíveis para cirurgia bariátrica por risco anestésico-cirúrgico elevado

4

Preparo pré-bariátrico

Redução ponderal prévia para viabilizar cirurgia com maior segurança

Perfil Ideal do Paciente



O sucesso terapêutico depende diretamente do **perfil comportamental e motivacional** do paciente. Os critérios fundamentais incluem:

→ **Motivação genuína**

Comprometimento real com o processo de emagrecimento

→ **Aderência ao acompanhamento**

Disponibilidade para consultas regulares com equipe multidisciplinar

→ **Mudança de estilo de vida**

Disposição para adotar hábitos alimentares e de atividade física sustentáveis

Contraindicações

Cirurgia Gástrica Prévia

Anatomia alterada compromete posicionamento seguro e eficácia do dispositivo

Úlcera Péptica Ativa

Risco aumentado de complicações hemorrágicas e perfuração

Distúrbios Graves do TGI

Acalasia, esofagite grave, varizes esofágicas ou hérnias volumosas

Transtornos Psiquiátricos

Compulsão alimentar grave ou condições que comprometam a adesão

 Avaliação endoscópica prévia é mandatória para identificar contraindicações anatômicas.



Benefícios Metabólicos

10–...

Perda ponderal

Do peso corporal total
ao longo do
tratamento

↓ Hb...

Controle do
diabetes

Melhora glicêmica
significativa em
pacientes com DM2

↓ PA

Redução da HAS

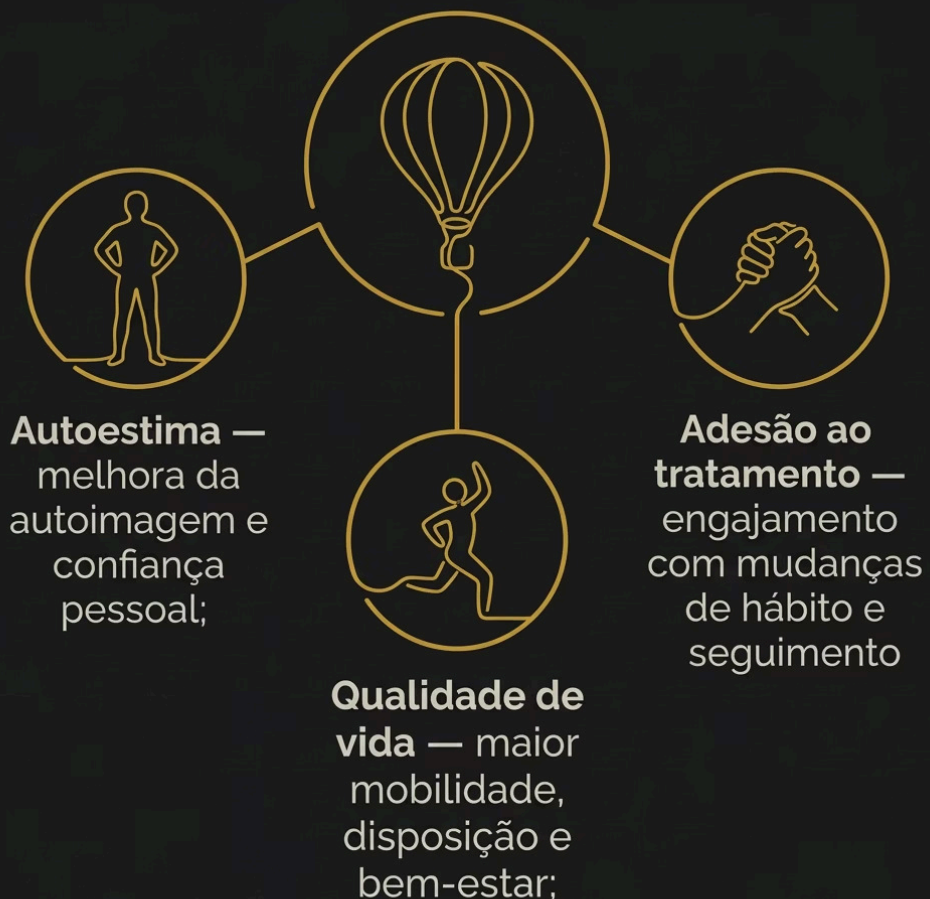
Diminuição da pressão
arterial sistêmica

↑ IAH

Apneia do sono

Melhora do índice
apneia-hipopneia

Impacto Psicossocial



Além dos efeitos metabólicos, o tratamento com balão intragástrico promove transformações significativas na **esfera psicossocial** do paciente:

- Melhora da autoimagem e da autoestima
- Aumento da disposição para atividades físicas e sociais
- Maior engajamento e adesão às mudanças de estilo de vida
- Redução de sintomas depressivos associados à obesidade

Avaliação Pré-Procedimento



Avaliação
clínica

Exames
laboratoriais

Avaliação
nutricional

Endoscopia
diagnóstica

A avaliação pré-procedimento garante a **elegibilidade e segurança** do paciente, identificando contraindicações e estabelecendo metas terapêuticas individualizadas com toda a equipe multidisciplinar.

Procedimento Endoscópico



O procedimento é realizado em ambiente hospitalar, com duração média de **20 a 30 minutos**, e não requer internação prolongada.

01

Sedação endovenosa

Monitorizada ou anestesia geral leve, com suporte anestesiológico

03

Inserção do balão

Introdução do dispositivo defletado via endoscópio até o estômago

02

Endoscopia diagnóstica

Confirmação da anatomia e ausência de lesões contraindicatórias

04

Posicionamento e preenchimento

Confirmação radioscópica e preenchimento com volume definido

Preenchimento do Balão

Composição do Fluido

O balão é preenchido com **solução salina estéril** acrescida de **azul de metileno** — corante que serve como marcador de segurança: em caso de ruptura do balão, a urina do paciente torna-se azulada, permitindo diagnóstico imediato.

Volume e Ajuste

- Volume inicial: 400–700 mL (individualizado)
- Ajuste possível a qualquer momento durante o tratamento
- Aumento para reforçar saciedade
- Redução para manejo de intolerâncias

❏ O azul de metileno é um diferencial de segurança único — permite detecção precoce e não invasiva de ruptura.

Pós-Procedimento Imediato

Nas primeiras 24–72 horas, é esperado um período de **adaptação fisiológica** ao dispositivo. Os principais sintomas são transitórios e manejáveis:

Náuseas e Vômitos

Muito frequentes na primeira semana; respondem bem a antieméticos

Desconforto Abdominal

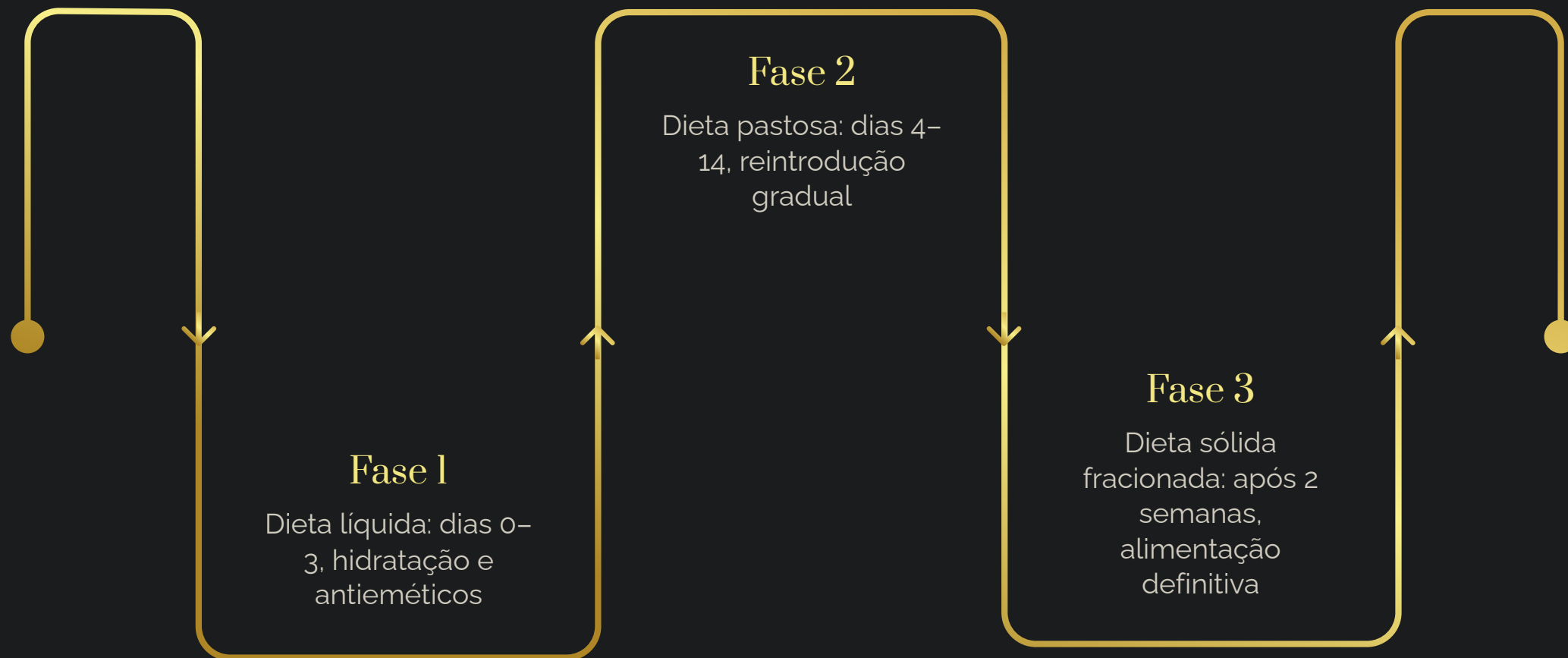
Cólicas e sensação de peso; geralmente autolimitados

Refluxo Gastroesofágico

Manejado com inibidores de bomba de prótons (IBP)



Manejo Inicial Pós-Procedimento



A progressão dietética estruturada, aliada ao uso de **antieméticos e IBP**, é fundamental para garantir conforto, adesão e segurança nas primeiras semanas após o procedimento.

Acompanhamento Multidisciplinar



Médico Endoscopista

Monitorização do dispositivo, ajustes de volume e manejo de complicações



Nutricionista

Reeducação alimentar, adequação calórica e suporte às metas de emagrecimento



Psicólogo

Suporte emocional, manejo de compulsão e fortalecimento da adesão



Educador Físico

Prescrição de atividade física individualizada e progressiva

Tempo de Permanência e Ajustes



Mês 1

adaptação e
manejo inicial

Meses 2-4

perda ponderal
progressiva com
acompanhamento

Meses 5-8

ajuste de
volume
conforme
resposta

Meses 9-12

consolidação
de hábitos e
preparação
para remoção

O balão Spatz permanece implantado por **6 a 12 meses**, período durante o qual o paciente é acompanhado continuamente.

- Ajustes de volume realizados conforme resposta clínica
- Consultas mensais com equipe multidisciplinar
- Avaliação periódica de comorbidades e metas
- Planejamento antecipado da fase pós-remoção

Remoção do Balão



A remoção é realizada por **via endoscópica**, em procedimento ambulatorial, com duração semelhante à inserção. O processo é seguro, controlado e bem tolerado.

01

Sedação e endoscopia

Mesmas condições do procedimento de inserção

03

Retirada do dispositivo

Balão defletado removido com pinça endoscópica

02

Punção e esvaziamento

O balão é puncionado e todo o fluido é aspirado

04

Alta hospitalar

Geralmente no mesmo dia, com plano de manutenção de hábitos

Resultados Esperados e Manutenção

10–15%

Perda do peso corporal

Resultado médio ao longo de 6 a 12 meses de tratamento

70%

Melhora das comorbidades

Dos pacientes relatam melhora metabólica significativa

- ❑ **A manutenção dos resultados depende da consolidação de hábitos alimentares e de atividade física adquiridos durante o tratamento.** O balão é uma ferramenta — a mudança de comportamento é o objetivo final.

